

Hipoglicemias – Generalidades

Hipoglicemias (Generalidades)

Es una complicación aguda potencialmente letal. Diferenciaremos de inmediato el cuadro clínico en relación con el compromiso neurológico y no al número de laboratorio estricto: la severidad depende de los síntomas.

Clínica de la Hipoglicemia

- **Síntomas Simpáticomiméticos (Leves):** Temblor, taquicardia, sudoración fría, palidez, inquietud, ansiedad (Activación autonómica en respuesta central hipotalámica).
- - *Nota:* Los Bloqueadores Beta (Propranolol, Atenolol) pueden asordar o enmascarar estos síntomas.
- **Síntomas Neuroglucopénicos (Graves):** Falla cerebral por déficit energético. Somnolencia, letargo, confusión, comportamiento extraño, focalidad piramidal, **convulsiones o compromiso de conciencia profundo (coma)**. Un paciente en esta etapa no puede autotratarse y está en peligro inminente.

Diagnóstico Confirmatorio: Tríada de Whipple

Especial para cuadros no documentados formalmente o como tamizaje en URGENCIAS: 1. Síntomas probables de hipoglicemia. 2. **Cifra química de laboratorio/hemoglucotest bajo constatada en ese mismo momento** (< 60, o < 55 según convención). 3. Reversión completa de la clínica al recuperar el nivel de glucosa celular.

Diagnósticos Diferenciales

Si el paciente tiene Tríada de Whipple clínica pero Hemoglucotest Normal: **Crisis de pánico/Ansiedad agitada**, Feocromocitoma o Tormenta Tiroidea.

Tratamiento de las Hipoglicemias

TABLA 2.20.1: TIPO VS VÍA / TRATAMIENTO		
TIPO	VÍA / TRATAMIENTO	EJEMPLO DE MANEJO
Hipoglicemia LEVE (paciente lúcido, vigila, que puede tragar)	Vía Oral. Carbohidratos de absorción rápida.	Bebida no dietética (Coca-Cola normal), jugo de fruta al 100%, 15 g miel/azúcar, seguido de algún carbohidrato rico para rematar (pan).
Hipoglicemia SEVERA (Signos neuroglucopénicos, o HGT < cierto rango que limite succión)	Vía Intravenosa. Bolo endovenoso de Glucosa al momento.	Sueros glucosados hipertónicos: de 15 a 25 gramos glucosa rápidos. (Ej: Ampollas Glaucosadas típicas de 30%).
Extra-Hospitalario / Prehospitalario	Glucagón Subcutáneo/Intramuscular	Usualmente recetado a pacientes DM1. Es un rescate.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Hipoglicemia por Sulfonilureas (Especialmente Glibenclamida)

Paciente tratado por hipoglicemia severa secundaria a Glibenclamida → **¡Nunca dar de alta directo!** La Glibenclamida tiene una t1/2 > 12-24h y en la medida que baje la glucosa EV, el paciente volverá a caer en coma. Deben hospitalizarse y quedar en observación bajo suero glucosado continuo al menos en URGENCIAS por unas horas o incluso un día completo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente diabético tipo 1 presenta sudoración profusa, temblor y palpitaciones. Glicemia capilar: 58 mg/dL. Está consciente y puede tragar. ¿Cuál es el tratamiento inmediato?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hipoglicemias - Generalidades. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La hipoglicemia se define por la tríada de Whipple
- Es la complicación aguda más frecuente del tratamiento de la diabetes
- Síntomas autonómicos (temblor, sudoración, taquicardia) aparecen primero como señal de alarma
- Síntomas neuroglucopénicos (confusión, convulsiones, coma) son más graves
- La hipoglicemia inadvertida pierde los síntomas de alarma por hipoglicemias recurrentes
- Tratamiento consciente: regla de los 15 (15 g carbohidratos, 15 min, remedir)
- Tratamiento inconsciente: glucagón IM 1 mg o glucosa EV al 30%

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPOGLICEMIAS - GENERALIDADES)**PREGUNTA 1**

Paciente diabético tipo 1 presenta sudoración profusa, temblor y palpitaciones. Glicemia capilar: 58 mg/dL. Está consciente y puede tragar. ¿Cuál es el tratamiento inmediato?

- A)** Glucagón intramuscular 1 mg
- B)** 15 gramos de carbohidratos de acción rápida por boca
- C)** Glucosa endovenosa al 30%
- D)** Insulina subcutánea
- E)** Observar sin intervención

PREGUNTA 2

Paciente diabético tipo 2 con múltiples episodios de hipoglicemia. Refiere que ya no siente temblor ni sudoración antes de las hipoglicemias. ¿Cómo se denomina este fenómeno?

- A)** Efecto Somogyi
- B)** Fenómeno del alba
- C)** Hipoglicemia inadvertida
- D)** Resistencia a la insulina
- E)** Neuropatía autonómica

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes es un síntoma neuroglucopénico de hipoglicemia?

- A)** Temblor
- B)** Palpitaciones
- C)** Confusión mental
- D)** Sudoración
- E)** Hambre intensa

RESUMEN: HIPOGLICEMIAS - GENERALIDADES

La hipoglicemia se define por la tríada de Whipple: síntomas compatibles con hipoglicemia, glicemia baja documentada (generalmente menor a 70 mg/dL en diabéticos, menor a 55 mg/dL en no diabéticos) y resolución de los síntomas al corregir la glicemia. Es la complicación aguda más frecuente del tratamiento de la diabetes y la principal limitante para lograr un control glicémico estricto. Los síntomas se dividen en autonómicos (adrenérgicos) y neuroglucopénicos. Los autonómicos aparecen primero: temblor, palpitaciones, sudoración, ansiedad, hambre y parestesias. Los neuroglucopénicos aparecen con glicemias más bajas: confusión, dificultad para concentrarse, alteración del habla, visión borrosa, convulsiones y pérdida de conciencia. La hipoglicemia inadvertida (unawareness) es un fenómeno peligroso donde el paciente pierde los síntomas de alerta adrenérgicos por hipoglicemias recurrentes. La clasificación según severidad incluye: nivel 1 (glicemia 54-70, con síntomas autonómicos), nivel 2 (glicemia menor a 54, síntomas neuroglucopénicos) y nivel 3 (hipoglicemia severa que requiere asistencia de terceros). El tratamiento inmediato de la hipoglicemia consciente es la regla de los 15: 15 gramos de carbohidratos de acción rápida, esperar 15 minutos, remedir. Si el paciente está inconsciente, se administra glucagón intramuscular 1 mg o glucosa endovenosa (30 mL de glucosa al 30%).